

## INTRODUCTION

Dans un contexte de vieillissement de la population, d'augmentation des besoins en soins et de tension hospitalière croissante, la fluidification des **sorties hospitalières** constitue un enjeu majeur de santé publique. Les situations complexes, notamment liées à la fragilité médicale ou sociale, peuvent prolonger les durées de séjours et favoriser les réhospitalisations précoces.

La **Plateforme d'Orientation Patients (POP)**, expérimentée de **2021 à 2024** au Centre Hospitalier de Saint-Brieuc en partenariat avec l'Hospitalisation à Domicile (HAD) du Pays Briochin (Fondation AUB Santé), visait à sécuriser et coordonner les sorties d'hospitalisations complexes. En s'inspirant notamment de dispositifs similaires sur les CHU de Nîmes, de Brest et de Saint-Malo<sup>1</sup>, cette expérimentation reposait sur l'intervention d'une infirmière experte réalisant une évaluation individualisée au chevet du patient afin de définir un plan de soins adapté à la sortie. Une coordination renforcée avec les professionnels de ville permettait d'assurer la continuité des soins.

À notre connaissance, il n'y a pas eu de travaux quantitatifs étudiant l'impact de ce type de dispositif en France. Cette présente étude propose de le faire en utilisant les indicateurs tels que les durées moyennes de séjours (DMS) et les taux de réhospitalisation à 30 jours<sup>2</sup>.

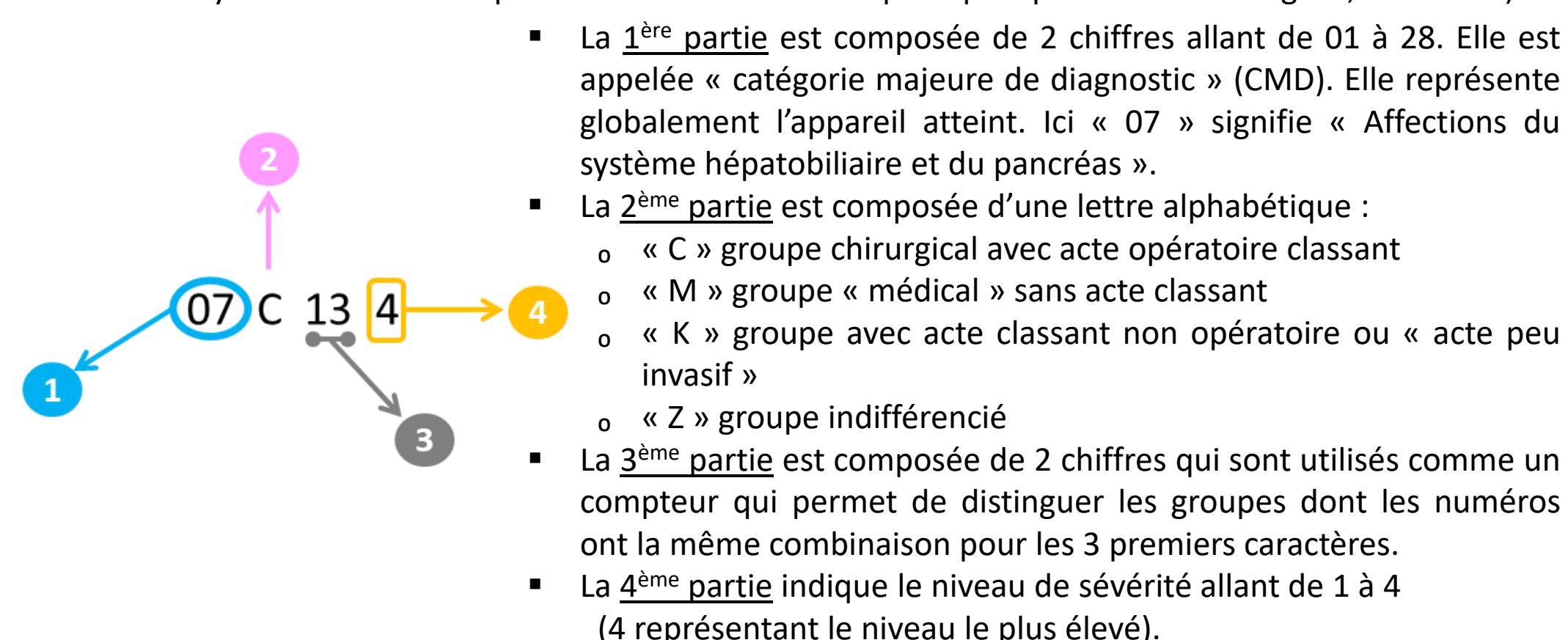
## MÉTHODES

Il s'agit d'une étude rétrospective monocentrique de type exposé/non-exposé.

Sources de données :

- **Groupe POP (exposé)** : cette information est issue des formulaires de demande et de suivi provenant du dossier médical, pour les patients ayant bénéficié de la POP (N=868) au cours du séjour dit « index ». La date d'entrée de ce séjour est considérée comme la date index.
- **Groupe non-POP (non-exposé)** : il s'agit de patients hospitalisés au cours de la même période que le groupe POP et partageant les mêmes caractéristiques medico-administratives (voir méthode d'appariement ci-dessous).
- **PMSI** : pour la période 2021–2024 contenant des informations médico-administratives sur les séjours hospitaliers.

**GHM** : Les informations médicales reposent sur la notion de Groupes Homogènes de Malades (GHM) définis à partir des diagnostics principaux et associés et des actes CCAM. Chaque GHM comporte 6 caractères pouvant être décrits comme suit à partir de l'exemple de GHM 07C134 dont le libellé est : « Cholécyctomies sans exploration de la voie biliaire principale pour affections aiguës, niveau 4 »).



Critères d'inclusion : Âge ≥ 65 ans ; durée de séjour ≥ 5 jours ; selections de GHM<sup>2</sup>, racines<sup>2</sup> et CMD ; séjours de chirurgie (« C ») ou médecine (« M ») ; niveau de sévérité 2 à 4 ; hors soins palliatifs.

Critères d'appariement :

- Âge ± 2 ans
- Sexe (femme/homme)
- Date index ± 15 jours
- Facteurs socio-environnementaux<sup>3</sup> (difficultés d'ordre social, personnel et liées à l'environnement de vie)
- Niveau de sévérité (2 à 4)
- Type de séjour (C ou M)
- Entrée par les urgences (oui/non)
- Score de Charlson<sup>4</sup> regroupé en 3 catégories (2-4 / 5 / 6 ≤)

Méthode d'appariement :

- **Score de propension** estimé par régression logistique (fonction matchit() du logiciel R).

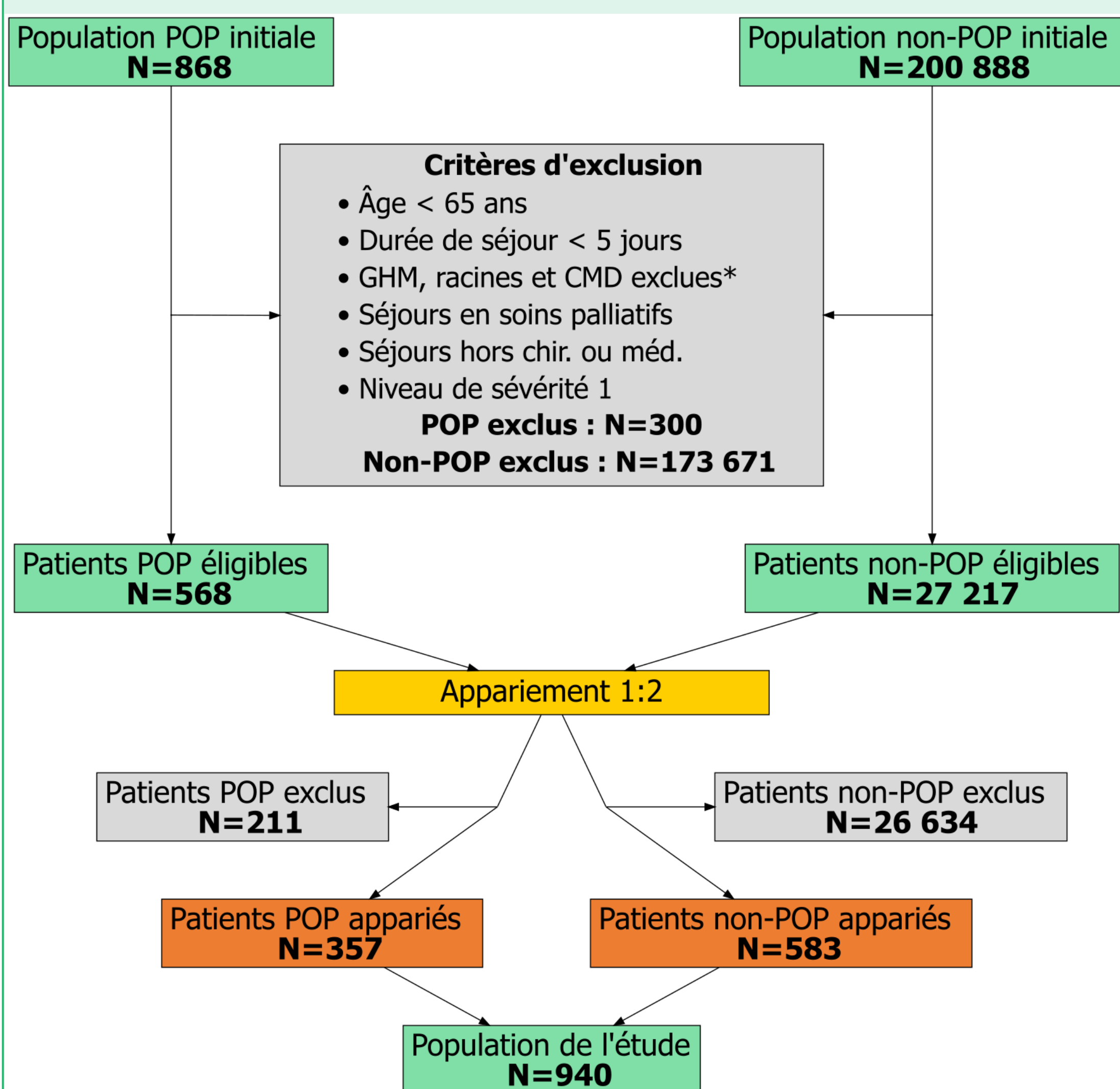


Figure 1 : Sélection de la population

\*GHM (23Z02T, 23Z02Z) ; Racines (02C05, 02C12, 11K02, 17M05, 17M06, 17K04, 17K05, 17K06, 17K08, 17K09, 23M09)<sup>2</sup> ; CMD avec un nombre de séjours < 10 (02, 03, 13, 18, 21, 25, 26).

Critères de jugement :

- **Durée moyenne de séjour index (DMS)** en nombre de jours.
- **Taux de réhospitalisation à 30 jours** correspond à la survenue d'une nouvelle hospitalisation dans les 30 jours suivant la date de sortie du séjour index.

## RÉSULTATS PRÉLIMINAIRES

| Variables                       | Groupe POP<br>N = 357* | Groupe non-POP<br>N = 583* | p-value** |
|---------------------------------|------------------------|----------------------------|-----------|
| Variables d'appariement         |                        |                            |           |
| Âge (ans)                       | 80.4 (74.0–86.0)       | 80.6 (74.0–86.0)           | 0.7       |
| Sexe                            |                        |                            | >0.9      |
| Femme                           | 196 (55%)              | 318 (55%)                  |           |
| Homme                           | 161 (45%)              | 265 (45%)                  |           |
| Type de séjour                  |                        |                            | 0.2       |
| Chirurgie                       | 29 (8.1%)              | 35 (6.0%)                  |           |
| Médecine                        | 328 (92%)              | 548 (94%)                  |           |
| Niveau de sévérité              |                        |                            | 0.4       |
| 2                               | 48 (13%)               | 76 (13%)                   |           |
| 3                               | 251 (70%)              | 430 (74%)                  |           |
| 4                               | 58 (16%)               | 77 (13%)                   |           |
| Facteurs socio-environnementaux |                        |                            | 0.6       |
| Oui                             | 168 (47%)              | 265 (45%)                  |           |
| Non                             | 189 (53%)              | 318 (55%)                  |           |
| Entrée par les urgences         |                        |                            | 0.4       |
| Oui                             | 314 (88%)              | 523 (90%)                  |           |
| Non                             | 43 (12%)               | 60 (10%)                   |           |
| Score de Charlson               |                        |                            | >0.9      |
| 2-3-4                           | 120 (34%)              | 197 (34%)                  |           |
| 5                               | 67 (19%)               | 107 (18%)                  |           |
| 6≤                              | 170 (48%)              | 279 (48%)                  |           |
| Critères de jugement            |                        |                            |           |
| DMS (jours)                     | 20.4 (11.0–26.0)       | 12.5 (7.0–15.0)            | <0.001    |
| Réhospitalisation à 30 jours    |                        |                            | 0.2       |
| Oui                             | 71 (20%)               | 97 (17%)                   |           |
| Non                             | 286 (80%)              | 486 (83%)                  |           |

Figure 2: Caractéristiques des groupes POP et non-POP

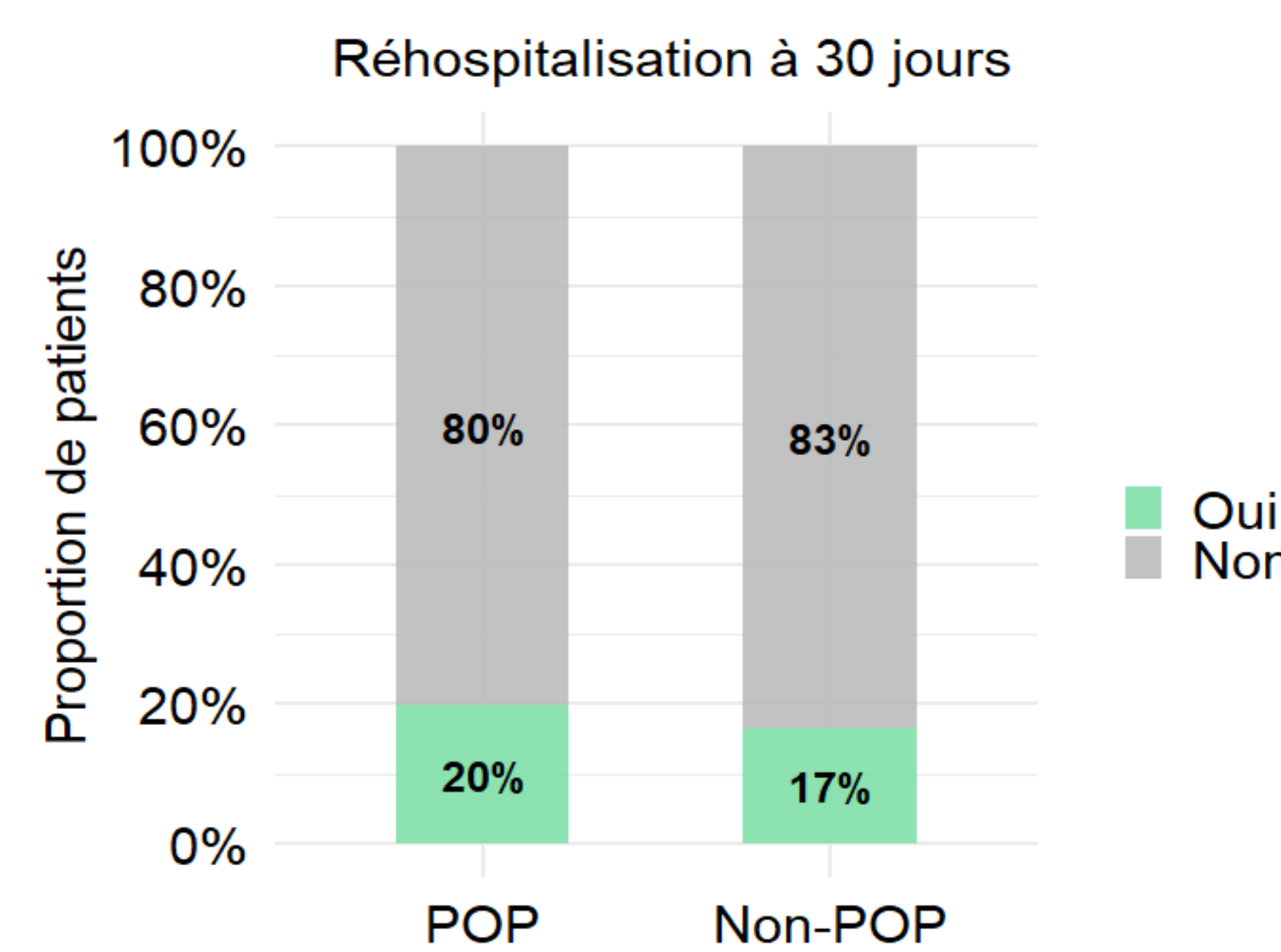


Figure 4 : Comparaison du taux de réhospitalisation à 30 jours selon le statut POP

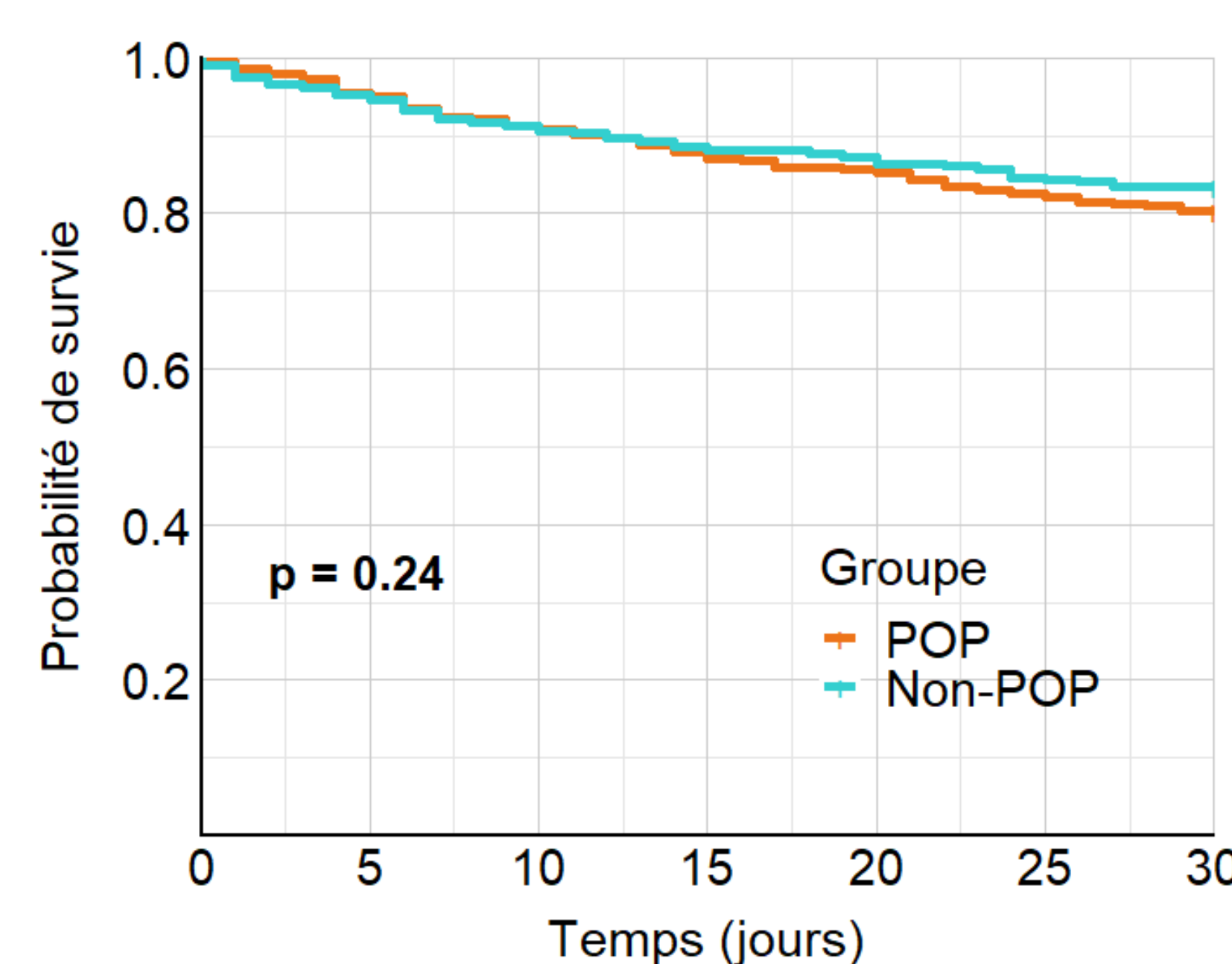


Figure 5 : Probabilité de survie à 30 jours selon le statut POP

## DISCUSSION

Ces résultats préliminaires montrent que la DMS des séjours index est plus élevée dans le groupe POP que dans le groupe non-POP. De même, le risque de réhospitalisation à 30 jours est légèrement plus élevé, mais non significatif, dans le groupe POP par rapport au groupe non-POP. Ces résultats peuvent être expliqués principalement par les limites d'appariement. En effet, les critères utilisés par le personnel soignant dans les services pour identifier les potentielles sorties complexes et sélectionner les patients pouvant bénéficier du dispositif ne peuvent pas être définis à partir des données PMSI. Ces résultats soulignent les limites d'une étude rétrospective dans l'évaluation du dispositif POP. Cependant, cette étude met à disposition des données de référence utiles sur la durée moyenne de séjour et les réadmissions à 30 jours pour les travaux ultérieurs.

## BIBLIOGRAPHIE

- <sup>1</sup> Gaboriau, M. Évaluation du dispositif POP (Plateforme Opérationnelle de Parcours) et de la communication entre ville et hôpital dans l'organisation des sorties d'hospitalisation complexes du centre hospitalier de Saint Malo. 2024
- <sup>2</sup> DGOS & ATIH. Les réhospitalisations à 30 jours (RH30). 2018
- <sup>3</sup> ATIH. Les facteurs socio-environnementaux - concept et codage pour le PMSI. 2021
- <sup>4</sup> Bannay, A. et al. The best use of the Charlson comorbidity index with electronic health care database to predict mortality. Med Care 54, 188–194. 2016